II度 Wenckebach 型洞房ブロックを鑑別し得た一例

◎土屋 実生[1)]、今吉 由美[1)]、伊藤 知子[1)]、神谷 嘉彦[1)]、清水 繁行[1)]、西村 拓摩[1)]、山田 直弥[1)]
大垣市民病院[1)]

【背景】洞房ブロック(SAB)は洞結節-心房間の伝導障害である。II度 SAB は心電図上で鑑別可能で Mobitz 型と Wenckebach 型に分類される。今回、ホルター心電図でII度 Wenckebach 型 SAB を鑑別し得た一例を報告する。
【症例】70 歳代男性。既往歴は高血圧、発作性心房細動(PAF)。PAF に対してカテーテルアブレーション施行歴がある。術後フォローアップ目的でホルター心電図を施行。
【心電図所見と臨床経過】ホルター心電図は終日洞調律。RR 間隔延長が散見され、いずれも RR 間隔延長部分に P 波は認められなかった。RR 間隔比 175%以上は 95 件あり、内訳は洞停止(2.3-4.5sec)、PAC with block、その他であった。その他に分類した RR 間隔延長部分では、PP 間隔が徐々に短縮し、その後に P-QRS 波が欠落するものと、P-QRS 波が欠落する前後で PP 間隔が整数倍になっているものがあり、これらをSAB疑いとした。最大4.5secの洞停止が認められ、患者のふらつき症状と一致したため後日ペースメーカ植込み術(PMI)を施行した。PMI 後ふらつき症状は消失した。
【総括】SAB は洞不全症候群(SSS)の Rubenstein 分類II群に該当する。心電図で確認されるII度 SAB は Mobitz 型と Wenckebach 型に分類され、Mobitz 型は突然洞房伝導が途絶するため、P-QRS 波が欠落した際の PP 間隔は洞調律時の整数倍となる。Wenckebach 型は洞房伝導時間が漸増後途絶するが、伸び率は漸減するため、PP 間隔が徐々に短縮した後、長い PP 間隔が出現する。本症例は P 波を伴わない RR 間隔の延長を認め、PP 間隔の変動の特徴から洞不整は否定され、また洞停止を認めたためII度以上の SAB が疑われた。II度 Wenckebach 型 SAB は臨床的意義がないとされているが、PAC with block や洞性不整脈との鑑別は必要と考える。SSS の一般的な原因には虚血性疾患や特発性変性が挙げられる。本症例では、それらの確証は得られなかった。一方で、PAF 治療歴や高血圧の背景により、組織や電気的な変化、加齢による変化も加わることで、洞結節周囲の伝導機能に影響を及ぼした可能性があると考えられる。
【結語】ホルター心電図解析で、II度 Wenckebach 型 SAB を鑑別し得た一例を経験した。
【連絡先】0584-81-3341(内線 1269)